Árbol de decisión — Tobillo y Pie

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Tobillo y pie. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

2 ¿Algún criterio de Ottawa de tobillo o de pie, Thompson positivo, o mecanismo de Lisfranc o de caída sobre el talón? → DERIVAR para radiografía (Ottawa) o derivación preferente (Aquiles, Lisfranc, calcáneo) antes de seguir explorando. 📝 R1, R2, R3

- OTTAWA DE TOBILLO POSITIVO → 37 Fractura de Tobillo (Maleolar)
- OTTAWA DE PIE POSITIVO → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- THOMPSON POSITIVO → 3 Rotura del Aquiles
- MECANISMO DE LISFRANC → 4 Lesión de Lisfranc
- CAÍDA SOBRE EL TALÓN → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- NINGUNO → sin hipótesis

3 Tobillo agudo traumático, ¿qué mecanismo cuenta? 📝 R1, R4

- ESGUINCE LATERAL → 1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)
- SINDESMOSIS → 2 Lesión de la Sindesmosis
- CALCANEOCUBOIDEA → 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana
- LUXACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR → 6 Luxación del Tibial Posterior
- NINGUNO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿Traumatismo agudo? 📝 G2, G3 · R1, R2, R3

NO

4 ¿Niño o adolescente con dolor bien localizado o sin mecanismo claro? 📝 G2 · R9

todas

5 ¿La exploración local no reproduce el dolor conocido? → COLUMNA LUMBAR u origen proximal: slump con flexión plantar e inversión. Si persiste la duda, replantear (malignidad). 📝 R9

todas

6 Dolor sin traumatismo en el tobillo, POSTERIOR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12

Respuestas

SÍ — Traumatismo agudo: Ottawa primero, después por mecanismo → → desvío 2

NO — Sin traumatismo: por edad y localización → sin hipótesis

Respuestas

SEVER — Inserción del Aquiles (8–12 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)

ISELIN — Base del 5.º MT (8–13 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)

APOFISITIS DEL TIBIAL POSTERIOR o KÖHLER — Navicular (menores de 10, cojera) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)

FREIBERG — Cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)

OSTEOCONDRITIS DISECANTE — Esguince que no se resuelve, bloqueo → 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo

OSTEOMA OSTEOIDE — Dolor nocturno con alivio rápido por AINE: derivar → sin hipótesis

NO — Adulto, o hay mecanismo claro → sin hipótesis

Respuestas

COLUMNA LUMBAR u origen proximal — El slump con flexión plantar e inversión reproduce: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis

NO REPRODUCE NADA — Persiste la duda: replantear (malignidad) → sin hipótesis

NO — La exploración local sí reproduce el dolor conocido → sin hipótesis

Respuestas

PINZAMIENTO POSTERIOR — Flexión plantar máxima → 7 Pinzamiento Posterior del Tobillo

AQUILES PORCIÓN MEDIA — Pinza, 2–6 cm → 8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media

AQUILES INSERCIONAL — Un dedo, flexión dorsal → 9 Tendinopatía Insercional del Aquiles

VAINA DEL AQUILES — Crepitación, rango amplio → 10 Afectación de la Vaina del Aquiles

PLANTAR DELGADO — Medial y proximal → 11 Tendinopatía del Plantar Delgado

NERVIO SURAL — Lateral, neuropático → 12 Neuropatía del Nervio Sural

BURSA SUPERFICIAL — Roce del zapato → 13 Bursitis Calcánea Superficial

NINGUNO — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →

7 Dolor sin traumatismo en el tobillo, MEDIAL: ¿qué lo explica? 📝 R5, R9, R11, R12

todas → **8 Dolor sin traumatismo en el tobillo, LATERAL: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R9, R10

Respuestas

- **TIBIAL POSTERIOR** — Retromaleolar, ETM sin varo del retropié → **14 Tendinopatía del Tibial Posterior**
- **FHL** — Transición de flexión dorsal a plantar → **15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)**
- **TÚNEL DEL TARSO** — Tinel → **16 Síndrome del Túnel del Tarso**
- **FRACTURA DE ESTRÉS** — Maléolo medial → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

8 Dolor sin traumatismo en el tobillo, LATERAL: ¿qué lo explica? 📝 R5, R9, R10

todas → **9 Dolor sin traumatismo en el tobillo, ANTERIOR: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R9, R10

Respuestas

- **SENO DEL TARSO** → **18 Síndrome del Seno del Tarso**
- **PERONEOS** → **19 Tendinopatía de los Peroneos**
- **ESTRÉS DEL ASTRÁGALO** → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **REFERIDO** — Valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

9 Dolor sin traumatismo en el tobillo, ANTERIOR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R9, R10

todas → **10 Dolor en el pie, TALÓN PLANTAR: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R8, R9, R11, R12

Respuestas

- **PINZAMIENTO ANTERIOR** — KTW (rodilla a la pared) → **20 Pinzamiento Anterior del Tobillo**
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o no lo explica → sin hipótesis

10 Dolor en el pie, TALÓN PLANTAR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R8, R9, R11, R12

toc

Respuestas

- **DOLOR PLANTAR CRÓNICO** — Tuberosidad medial → **26 Dolor Plantar Crónico del Talón**
- **ALMOHADILLA GRASA** — Posterolateral → **27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón**
- **ATRAPAMIENTO NERVIOSO** — Tinel → **28 Atrapamiento Nervioso del Talón**
- **ESTRÉS DEL CALCÁNEO** → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el talón plantar o nada de esto lo explica → sin hipótesis

11 Dolor en el pie, MEDIOPIÉ: ¿qué lo explica? 📝 R4, R5, R11, R12

todas → **12 Dolor en el pie, ANTEPIÉ: ¿qué lo explica?** 📝 R1, R5, R9, R10, R11

Respuestas

- **CALCANEOCUBOIDEA** → **29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana**
- **NAVICULAR (punto N), CUBOIDES O CUÑAS** — Fractura de estrés → **30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)**
- **LISFRANC** → **4 Lesión de Lisfranc**
- **COALICIÓN** → **23 Coalición Tarsiana**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el mediopié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

12 Dolor en el pie, ANTEPIÉ: ¿qué lo explica? 📝 R1, R5, R9, R10, R11

todas → **13 DOLOR VAGO DEL TOBILLO o que no se resuelve tras un esguince: ¿qué lo explica?** 📝 R4, R7, R9, R10

Respuestas

- **1.ª MTF** → **31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica**
- **BASE DEL 2.º MT** → **32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano**
- **CUELLO DE MT** — Fractura de marcha → **33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)**
- **5.º MT** — Fractura → **5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)**
- **MORTON** — O bursitis intermetatarsiana → **34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana**
- **GOTA** — Derivar para confirmar (con fiebre y malestar → artritis infecciosa: urgencia) → **35 Gota**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el antepié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Respuestas

- **INESTABILIDAD CRÓNICA** → **21 Inestabilidad Crónica del Tobillo**
- **SINDESMOSIS** → **2 Lesión de la Sindesmosis**
- **SINOVITIS POSTRAUMÁTICA** → **22 Sinovitis Postraumática**
- **COALICIÓN TARSIANA** → **23 Coalición Tarsiana**
- **ARTROSIS** → **24 Artrosis de Tobillo o Pie**
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** → **25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo**
- **NINGUNO** — Sin dolor vago o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis
- 📝 Formulario del paciente (G general, R región)

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de tobillo y pie inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de tobillo y pie.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0